

Atendimento no Domicílio e o Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU)

O atendimento no domicílio é um serviço que garante o acesso à assistência social para pessoas que não conseguem se deslocar até o CRAS. Este tópico apresenta o conceito do serviço e o instrumento usado para planejá-lo, o PDU.

PRINCIPAIS APRENDIZADOS

- A finalidade do serviço é prevenir situações de risco, exclusão e isolamento social, garantindo que o atendimento chegue a quem não consegue acessar o CRAS fisicamente.
- O atendimento domiciliar é voltado a pessoas com barreiras de deslocamento — geográficas, sociais, idade avançada ou deficiência — que não conseguem ir até o CRAS.
- É um serviço de caráter preventivo: evita o rompimento de vínculos familiares e o abrigo institucional, fortalecendo a rede de suporte no próprio domicílio.
- O público-alvo compreende pessoas idosas e pessoas com deficiência com mobilidade reduzida, ou que enfrentam barreiras geográficas e sociais de acesso. O serviço é obrigatoriamente referenciado e vinculado ao CRAS, integrando-se à rede local.
- O Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU) é o instrumento central de planejamento e execução do serviço no domicílio, focado nas necessidades específicas do indivíduo.
- O PDU se assemelha ao Plano de Acompanhamento Familiar (PAF), mas prioriza a identificação de vulnerabilidades e potencialidades do usuário idoso ou com deficiência, podendo coexistir com o acompanhamento familiar em casos de famílias extensas.
- A construção do PDU deve ser participativa: elaborado pela equipe técnica do CRAS em conjunto com o usuário e sua família, garantindo o protagonismo dele no processo de cuidado.

- A capacidade de atendimento por equipe costuma ser de até 20 usuários. O serviço combate a invisibilidade dessas pessoas nas políticas públicas e ajuda a prevenir custos com institucionalização.
- Entre os principais desafios estão a qualificação constante das equipes, a logística de deslocamento e a comunicação entre o domicílio, o CRAS e a rede de saúde local.
- É importante não confundir o atendimento no domicílio com o SCFV: enquanto o SCFV trabalha a coletividade, o atendimento domiciliar é sempre focado no indivíduo.

OBJETIVOS CENTRADOS NA AUTONOMIA E CIDADANIA

- Autonomia: focar nas necessidades e potencialidades individuais para promover a independência do usuário.
- Inclusão social: equiparar oportunidades e incentivar a participação na vida comunitária.
- Acesso à rede: garantir o acesso a políticas de saúde, educação, trabalho e transporte.
- Ações extensivas: apoiar e orientar familiares e cuidadores para elevar a qualidade de vida do usuário.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DE UM PDU EFICAZ

- Identificação: dados detalhados do usuário, contexto familiar e mapeamento do território de abrangência.
- Metas: objetivos claros, mensuráveis e viáveis para a superação das vulnerabilidades identificadas.
- Ações: intervenções específicas, como visitas domiciliares, encaminhamentos e orientações técnicas.
- Prazos: períodos definidos para a execução de cada ação e datas para reavaliação do plano.
- Responsabilidades: definição clara dos papéis da equipe técnica, da família e do próprio usuário no processo.

INTEGRAÇÃO ENTRE O PAIF E O ATENDIMENTO NO DOMICÍLIO

- A intrassetorialidade garante que a família e o indivíduo recebam proteção integral e complementar, já que os dois serviços fazem parte da mesma rede de assistência social.
- Papel do PAIF: é o eixo central do trabalho social com famílias no CRAS, identifica a necessidade de inclusão no serviço domiciliar e fortalece a capacidade protetiva do grupo familiar.
- Papel do atendimento domiciliar: amplia o alcance do CRAS para usuários com mobilidade reduzida, oferece suporte técnico direto ao cuidador e evita a sobrecarga da família.

IMPACTOS REAIS NA QUALIDADE DE VIDA

- Combate ao isolamento: redução drástica da solidão e do confinamento de idosos e pessoas com deficiência.
- Visibilidade social: torna "visíveis" indivíduos que antes estavam fora do alcance das políticas públicas.
- Prevenção de custos: evita internações e acolhimentos institucionais de alto custo emocional e financeiro.
- Desafios de gestão: equipes multidisciplinares qualificadas, logística territorial para áreas remotas e articulação constante entre o domicílio, o CRAS e a rede de saúde.